

0.4~0.8 mg, 以后视病情给静滴维持直至苏醒。除死亡者外,其余 8 例于停药后未发生停药综合征。因病例少,对纳洛酮使用剂量尚无较成熟意见。

4 小结

一些地区的某些人群,药物滥用情况严重,发生海洛因急性中毒病例呈上升趋势。因此,临床医学、药学工作者必须积极予以关注,积累临床抢救经验,及时交流,为临床探索新的预防、治疗和康复措施提供重要依据。

参考文献

- 1 杨国栋,周文华. 中国药物依赖性杂志,1998,7(3):181
- 2 陈新谦,金有豫. 新编药理学. 14 版. 北京:人民卫生出版社,1998,612
- 3 荣成. 纳洛酮不是“安全药”. 中国医学论坛报. 1997,2.6:5
- 4 邓跃林,罗字宏,曾敬友. 中华内科杂志,1997,36(9):619
- 5 鲍光欣,秦亚英,赵秀芬. 实用医学杂志,1998,14(2):96

(收稿日期:1998-12-21)

谈酒与药物相互作用引起的不良反应

于增智 吴永善

(山东省青岛市第三人民医院 青岛 266041)(山东省青岛医学院第二附属医院 青岛 266042)

于春华

酒是人们日常生活中经常饮用的一种饮料,但它还具有特殊的药理作用。少量饮酒可以起到扩张血管、加速血液循环和消除疲劳的作用。但患者在服药期间饮酒有害而无害。事实证明,酒与很多药物能相互作用产生不良反应,影响药物的疗效,主要有以下几个方面:

1 影响药物的吸收

1.1 酒可使 VB_1 、 VB_{12} 、烟酸、地高辛吸收减少。

1.2 酒可使茶碱吸收增加,还可使缓释剂溶解而失去缓释作用,造成缓释片中药物迅速释放,从而使药物不良反应增加。

2 酶促或酶抑作用

2.1 酶促作用

2.1.1 酒精慢性中毒患者体内,肝酶数量增加、肝内质网增生、药物氧化酶数量升高,可使苯妥英钠、鲁米那、安乃近、降糖灵、丙酮双香豆素、华法林等代谢速度加快,半衰期缩短,药效降低。

2.1.2 糖尿病人使用口服降糖药 D-860,同时饮酒可使半衰期缩短,降糖时间缩短,但酒与胰岛素、D-860、优降糖、降糖灵有协同作用。可引起低血糖的危险和不可逆的神经系统病变(头晕、呕吐、精神失常、平衡失调、惊厥、昏迷等),严重的能引起死亡。这是因为乙醇在体内氧化时使肝细胞中脱氢酶等的辅酶还原型降低,递氢作用减弱,阻碍了甘油乳酸和某些氨基酸转变为糖的异生过程,而胰岛素和降糖药也都有抑制糖异生的作用,因此可引起低血糖。

2.1.3 三环类抗抑郁药多虑平、丙咪嗪、去甲丙咪嗪、阿米替林都是在肝脏内中代谢产生活性成分才能发挥作用,饮酒可起到肝药酶诱导作用,所以使代谢活性产物增多,抗抑郁作用增强,同时也有中毒的危险。

2.2 酶抑作用 长期大量饮酒,使肝脏受损,肝内质网发生脱粒,从而使药酶质量下降,此时表现为酶抑作用,使药物半衰期延长,产生药物中毒。据报道服用苯巴比妥时大量饮酒,可发生猝死。另外服用单胺氧化酶抑制剂时饮酒可产生恶

心、腹痛、头晕、呼吸困难、心律失常、昏迷等不良反应,这是因为单胺氧化酶被抑制后,体内的去甲肾上腺素不易被破坏而导致含量升高,增加了人体对酒精的敏感性。这类药物对单胺氧化酶的抑制不可逆,因此在停药二周内也不应饮酒。

3 非微粒体酶系被抑制造成不良反应

乙醇在代谢过程中,在非微粒体酶的参与下,将乙醇转变为乙醛,又进一步转变为乙酸。在乙醛转化为乙酸的过程中,需要醛脱氢酶的参与。而很多药物能抑制醛脱氢酶的活性,阻断乙醛转变为乙酸的过程,使体内乙醛蓄积,出现乙醛中毒症状(主要为呼吸困难,低血压、胃肠道反应、头晕、头痛等),这样的药物有:灭滴灵、氯霉素、硝酸甘油、氯丙嗪、苯海拉明、消心痛、头孢羟唑等。

另外维生素 A(醇型)在体内代谢时,经过醇脱氢酶的作用转化为维生素 A(醛型)而起作用,但由于乙醇与醇脱氢酶亲和力强,竞争性抑制了维生素 A(醛型)的形成,从而降低了维生素 A 的疗效。

4 对药效的影响

乙醇有扩血管作用,所以与罂粟碱、氨茶碱、立其丁合用时血压下降显著,与利血平、氢氯噻嗪、速尿合用可引起体位性低血压。

乙醇与阿司匹林、消炎痛合用可引起胃溃疡,与扑热息痛合用可引起严重肝坏死及急性肾衰竭。

乙醇能加重利福平、甲氨蝶呤对肝的损害。

乙醇与安定、杜冷丁、吗啡合用能严重抑制中枢,严重者可引起死亡。

乙醇可降低血中钾离子浓度,使洋地黄类药物敏感性增加,可引起中毒,影响 β 受体阻滞剂的代谢,使心得安消除时间延长。

综上所述,酒与很多药物能相互作用,产生不良反应。因此患者在治疗期间应尽量避免饮酒,以免产生严重后果。

(收稿日期:1999-03-19)

血塞通注射液引起严重过敏反应 1 例

于长兰

(天津市南开区东南角医院 天津 300090)

血塞通注射液主要成分为三七总皂甙,主用于脑血管病后遗症、脑梗塞、脑血栓、脑缺血及视网膜中央静脉阻塞、眼前房出血等。一般未见明显毒副作用,仅个别病例出现咽干、头昏和心慌,停药后即恢复正常。该药引起严重过敏反应的病例报道较少。现将我院收治的 1 例报告如下:

某患者,女性,60 岁,因患脑梗塞就诊。查体 $T 36.4^{\circ}C$, $P 88$ 次/分, $R 20$ 次/分, $BP 19/12kPa$,心电图示轻度心肌缺血,尿糖(+ +)。遵嘱给 0.9% 盐水 500 ml 加血塞通 400 mg 静脉滴注,当液体进入 300 ml 时,病人出现胸闷、心悸、气短、呕吐。查体: $P 130$ 次/分, $BP 21/14kPa$,立即停药,更换液体,给予氧气吸入以及地塞米松、肾上腺素等抗过敏药物治疗,同时密切观察病情变化。约 30 分钟后,患者呼吸、脉搏、血压恢复正常。

(收稿日期:1999-04-15)